

Multidyscyplinarność — *standard, nie luksus*

Psychoterapeuta pracujący samotnie z pacjentem z AN działa nie zgodnie ze standardami. Każdy przypadek wymaga zespołu (min. 2 specjalistów).

CZAS: 15 min psychoedukacji + organizacja **REALIZACJA:** każdy pacjent z AN — od pierwszej konsultacji

ŹRÓDŁO: NICE (2017, NG69); AED Medical Care Standards (2021); APA (2010); Treasure i in. (2020)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **sześć ról zespołu**. W sekcji 02 — **współpraca operacyjna**: meetingi, komunikacja, spójność. Sekcja 03 — **mój zespół**.

DLACZEGO TO DZIAŁA

AN wymaga zespołu interdyscyplinarnego — psychoterapeuta pracujący samotnie *nie* działa zgodnie ze standardami (NICE NG69, 2017; AED, 2021). Standardowy zespół: **lekarz** (monitorowanie medyczny, MEED, refeeding), **dietetyk specjalistyczny ED** (plan rehabilitacji), **psychoterapeuta** (CBT-E lub MANTRA), **psychiatra** (komorbidność, farmako), w razie potrzeby rodzina i szkoła. Brak koordynacji = ryzyko medyczne lub osłabienie terapii. Komunikacja między członkami zespołu — co 4–6 tyg.

01 Sześć ról zespołu — kto za co odpowiada

ROLA	ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
1 · Psychoterapeuta	CBT-E, MANTRA, FBT (młodzież). Praca z obrazem ciała, motywacją, rodziną. <i>Nie</i> jest lekarzem prowadzącym.
2 · Psychiatra	Diagnostyka różnicowa, farmakoterapia komorbidności (depresja, lęk, OCD), decyzje o hospitalizacji psychiatrycznej.
3 · Lekarz prowadzący (POZ / internista)	Monitorowanie parametrów (waga, tętno, ciśnienie), zlecenia badań, decyzje o hospitalizacji medycznej.
4 · Dietetyk kliniczny ED	Plan refeedingu, edukacja żywieniowa, planowanie posiłków. <i>Specjalistyczny w ED</i> , nie „fit dietetyk”.
5 · Lekarz specjalista	Kardiolog, gastroenterolog, ginekolog, endokrynolog — wg konkretnych powikłań i potrzeb.
6 · Pracownik socjalny / FBT	W FBT u młodzieży: praca z rodziną, koordynacja szkoły, wsparcie środowiskowe.

02 Współpraca operacyjna — meetingi, komunikacja, spójność

KOORDYNATOR

Jedna osoba (zwykle psychiatra lub psychoterapeuta z największym doświadczeniem ED) integruje plan, komunikuje, jest punktem kontaktu.

MEETINGI CO 2–4 TYG.

Pacjenci aktywni — co 2–4 tyg. Stabilni — rzadziej. Wymiana obserwacji, korekta planu. Krótkie (15–30 min).

SPÓJNOŚĆ KOMUNIKATU

Pacjent słyszy **ten sam** komunikat od wszystkich. Zapobiega *splittingowi* („dietetyk mówi co innego niż terapeuta”).

03 Mój zespół — kto jest, kogo brakuje

KTO JUŻ JEST W MOIM ZESPOLE

— psychoterapeuta, lekarz POZ, psychiatra, dietetyk; wpisz imię i nazwisko, telefon, najbliższą wizytę

KOGO BRAKUJE

— najczęściej brakuje dietetyka ED lub psychiatry; jak szukać, gdzie skierowanie

KTO JEST KOORDYNATOREM

— jedna osoba; jeśli nie ma — ustal kto i kiedy

PISEMNA ZGODA NA WYMIANĘ INFORMACJI

— RODO; podpisana z każdym członkiem zespołu; przykład dokumentu od koordynatora

Klucz: psychoterapeuta pracujący *samotnie* z pacjentem z AN *nie* działa zgodnie ze standardami opieki. NICE NG69 (2017), AED (2021): każdy pacjent z AN wymaga zespołu multidyscyplinarnego. Minimum: psychoterapeuta + lekarz prowadzący. Ciężkie przypadki: pełny zespół z dietetykiem ED, psychiatrą, specjalistami. **Spójność komunikatu** jest krytyczna — pacjent słyszy ten sam komunikat od wszystkich, co zapobiega *splittingowi* („dietetyk mówi co innego niż terapeuta”). Splitting jest częsty w AN — pacjent (czasem nieświadomie) szuka „słabego ogniwa” w zespole, które poprze restrykcję. Dietetyk **MUSI** być specjalistą w ED — „fit dietetyk” zajmujący się dietami odchudzającymi *szkodzi* pacjentowi z AN. **W Polsce:** jeśli specjalistyczny ośrodek ED jest niedostępny, koordynacja przez psychiatrę lub psychoterapeutę z doświadczeniem ED. Lista dietetyków ED — przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub konsultacje w specjalistycznych ośrodkach.

△ *Pisemna zgoda pacjenta (lub rodziców u młodzieży) na wymianę informacji między członkami zespołu obowiązkowa (RODO). Bez zgody komunikacja jest utrudniona, ale lekarz pierwszego kontaktu i psychoterapeuta mogą rozmawiać w sytuacji zagrożenia życia. W razie ostatecznych decyzji medycznych zgoda nie jest wymagana, gdy stan zagraża życiu.*